

TEMA 7.18 • PSIQUIATRÍA GENERAL

# Consumo de Sustancias: Dependencia, Abuso y Entrevista Motivacional

PERFIL EUNACOM 5.01.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Los trastornos por consumo de sustancias representan un desafío mayor en la salud pública chilena. Es fundamental para el examen EUNACOM distinguir entre los conceptos básicos, identificar las complicaciones de las drogas más frecuentes y manejar las etapas del cambio en la entrevista motivacional.

## Conceptos Fundamentales

Es común confundir términos en el área de adicciones, pero para fines clínicos y de examen, cada uno tiene una definición precisa:

TABLA 7.18.1: TÉRMINO VS DEFINICIÓN

| TÉRMINO                            | DEFINICIÓN                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependencia</b>                 | Sinónimo de adicción. Estado donde el consumo de la sustancia es prioritario para el individuo. |
| <b>Abstinencia</b>                 | Malestar físico y psicológico al suspender o disminuir bruscamente el consumo habitual.         |
| <b>Tolerancia</b>                  | Necesidad de dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto inicial.                       |
| <b>Abuso / Consumo Perjudicial</b> | Consumo que genera daño a la salud física, mental o a las relaciones interpersonales.           |
| <b>Intoxicación</b>                | Síndrome agudo transitorio debido a la presencia de la sustancia en el organismo.               |
| <b>Craving (Avidez)</b>            | Deseo intenso e irresistible por consumir la sustancia.                                         |

### NOTA CLÍNICA

La **dependencia** se considera hoy dentro del espectro de los **Trastornos por Consumo de Sustancias**. Aunque algunos criterios se consideran "clásicos", siguen siendo útiles para el diagnóstico: - Pérdida de tiempo excesiva para conseguir, consumir o recuperarse de la sustancia. - Consumo en cantidades mayores a las planificadas. - Intentos fallidos de abandono. - Consumo persistente a pesar de conocer los problemas médicos, laborales o familiares que causa.

## Drogas de Consumo Frecuente en Chile

### 1. Marihuana (Cannabis)

Existe una falsa creencia de que por ser "natural" no es perjudicial. Sin embargo, su impacto en la salud mental es significativo.

- **Síndrome Amotivacional:** Caracterizado por apatía, falta de metas, deserción escolar y deterioro en el desempeño laboral. El paciente suele no tener conciencia de este deterioro.
- **Relación con Esquizofrenia:** El consumo de marihuana puede duplicar o triplicar el riesgo de desarrollar esquizofrenia en personas con predisposición genética.
- **Uso Medicinal:** Está validado bajo prescripción médica estricta para el manejo de dolor crónico intratable (ej. cáncer) y para estimular el apetito en cuadros de inapetencia grave.

### 2. Cocaína y Pasta Base

La cocaína es un potente estimulante con un rango de seguridad estrecho.

- **Fisiopatología:** Produce un **síndrome adrenérgico** agudo.
- **Riesgos:** Puede causar **Infarto Agudo al Miocardio**, arritmias graves y accidentes vasculares encefálicos debido a la vasoconstricción severa.
- **Pasta Base:** Es el residuo del procesamiento de la cocaína, mezclado con sustancias tóxicas. Es altamente adictiva y prevalente en

sectores vulnerables.

### ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En una intoxicación aguda por cocaína, está **absolutamente contraindicado el uso de Beta-bloqueadores**. Bloquear los receptores beta deja el estímulo alfa sin oposición, lo que puede causar una crisis hipertensiva masiva y vasoespasmio coronario letal.

### PERLA CLÍNICA EUNACOM

El manejo inicial de la intoxicación por cocaína incluye: 1. Soporte vital y cardiovascular. 2. **Electrocardiograma (ECG)** para descartar isquemia o arritmias. 3. **Benzodiacepinas** como antídoto principal para disminuir el estímulo cerebral y adrenérgico.

## Manejo Terapéutico: La Entrevista Motivacional

El diagnóstico es **clínico**. El tratamiento se basa en la psicoterapia cognitivo-conductual y un enfoque multidisciplinario. La herramienta clave es identificar en qué etapa de cambio se encuentra el paciente:

- **Etapas Precontemplativa:** El paciente no reconoce el problema ("la marihuana me hace bien").
  - **Acción:** Dar consejo médico claro sobre los riesgos sin confrontar excesivamente.
- **Etapas Contemplativa:** Reconoce que hay problemas pero tiene ambivalencia (disfruta el consumo).
  - **Acción:** Pesar en una balanza los perjuicios vs. beneficios y buscar alternativas para obtener esos beneficios de forma sana.
- **Etapas de Preparación:** Decide que quiere dejarlo en un futuro cercano.
  - **Acción:** Iniciar metas pequeñas, como reducir la frecuencia o cantidad del consumo.
- **Etapas de Acción:** El paciente está ejecutando el plan de abandono.
  - **Acción:** Implementar el programa de adicciones (psicoterapia, grupos de pares, intervención familiar).
- **Etapas de Mantención:** El paciente ya está en abstinencia.
  - **Acción:** Refuerzo positivo y **prevención de recaídas** (identificar gatillantes como el estrés).

## Farmacoterapia de Apoyo

Los fármacos no reemplazan la terapia, pero ayudan en fases específicas:

- **Disulfiram (Antabús):** Fármaco aversivo para el alcohol. Si el paciente bebe, sufre una reacción física muy desagradable (náuseas, taquicardia).
- **Naltrexona y Acamprosato:** Fármacos desmotivantes. Disminuyen el placer asociado al consumo de alcohol.
- **Bupropión y Vareniclina:** Utilizados principalmente para el tabaquismo, ayudan a disminuir el **craving** (avidez).

## Estrategias de Salud Pública

- **Factores Protectores:** Fomentar el deporte, organizaciones vecinales, estabilidad escolar y salud mental familiar.
- **Reducción de Daños:** Estrategia de última línea para pacientes que no logran la abstinencia, buscando que el consumo ocurra en entornos protegidos para evitar riesgos mayores (accidentes, violencia).
- **Criminalización:** La evidencia muestra que criminalizar al consumidor lo aleja del sistema de salud, dificultando su recuperación.

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Hombre de 25 años fuma marihuana diariamente desde hace 3 años. Abandonó la universidad, no trabaja y refiere que "todo está bien, la marihuana no me hace nada". Su madre refiere que es una persona diferente a quien era antes, sin proyectos. ¿Cuál es el cuadro más probable y en qué etapa de la entrevista motivacional se encuentra?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Consumo de Sustancias: Dependencia, Abuso y Entrevista Motivacional. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- Dependencia ≠ abstinencia ≠ tolerancia: son conceptos distintos que pueden coexistir o no.
- El síndrome amotivacional por cannabis genera desmotivación y deserción escolar; pasa desapercibido para el propio consumidor.
- La marihuana en personas con predisposición genética puede duplicar o triplicar el riesgo de esquizofrenia.
- Betabloqueadores contraindicados en intoxicación por cocaína (síndrome adrenérgico); usar benzodiazepinas.
- Disulfiram es aversivo (provoca resaca severa si se consume alcohol); naltrexona y acamprosato son desmotivadores; bupropión/vareniclina reducen el craving.
- Etapas de la entrevista motivacional: precontemplativa → contemplativa → preparación → acción → mantención.
- El objetivo del tratamiento de adicciones siempre es la abstinencia; la minimización de daños es la última opción cuando la abstinencia no es posible.

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (CONSUMO DE SUSTANCIAS: DEPENDENCIA, ABUSO Y ENTREVISTA MOTIVACIONAL)****PREGUNTA 1**

Hombre de 25 años fuma marihuana diariamente desde hace 3 años. Abandonó la universidad, no trabaja y refiere que "todo está bien, la marihuana no me hace nada". Su madre refiere que es una persona diferente a quien era antes, sin proyectos. ¿Cuál es el cuadro más probable y en qué etapa de la entrevista motivacional se encuentra?

- A)** Intoxicación aguda por cannabis; etapa de acción
- B)** Síndrome amotivacional por cannabis; etapa precontemplativa
- C)** Dependencia al cannabis con consciencia del problema; etapa contemplativa
- D)** Esquizofrenia inducida por cannabis; etapa de preparación
- E)** Trastorno de personalidad antisocial; psicoterapia

**PREGUNTA 2**

Mujer de 32 años acude a control porque quiere dejar de fumar y le pregunta al médico qué medicamento puede usar. Refiere que ya intentó dejarlo 2 veces sin éxito. ¿Cuál es el fármaco de elección?

- A)** Disulfiram
- B)** Naltrexona
- C)** Vareniclina (Champix) o bupropión
- D)** Lorazepam para el síndrome de abstinencia al tabaco
- E)** Carbonato de litio

**PREGUNTA 3**

Paciente de 35 años con consumo perjudicial de marihuana reconoce que le ha generado problemas en el trabajo y con su pareja, pero dice "me gusta y no quiero dejarlo". ¿En qué etapa de la entrevista motivacional se encuentra y cuál es la conducta?

- A)** Etapa precontemplativa; no hacer nada
- B)** Etapa contemplativa; reflexionar sobre perjuicios vs beneficios y buscar alternativas
- C)** Etapa de preparación; iniciar plan de abstinencia
- D)** Etapa de acción; iniciar psicoterapia cognitivo-conductual intensiva
- E)** Etapa de mantención; prevención de recaídas

**RESUMEN: CONSUMO DE SUSTANCIAS: DEPENDENCIA, ABUSO Y ENTREVISTA MOTIVACIONAL**

Los trastornos por consumo de sustancias requieren conocer los conceptos básicos: dependencia (adicción), abstinencia (malestar al dejar de consumir), tolerancia (necesidad de mayor dosis para el mismo efecto), abuso o consumo perjudicial (consumo que genera daño), intoxicación (síndrome agudo por consumo) y craving (deseo intenso por consumir). Los criterios de dependencia incluyen: pérdida de tiempo relacionada al consumo, síndrome de abstinencia, tolerancia, consumo superior a lo planificado, intentos fallidos de dejar, y consumo a pesar de daño laboral, médico o familiar. Las drogas más frecuentes en Chile son marihuana, cocaína y pasta base. La marihuana genera el síndrome amotivacional (desmotivación, deserción escolar, deterioro laboral) y aumenta el riesgo de esquizofrenia en personas con predisposición genética. La cocaína produce síndrome adrenérgico agudo y puede causar infarto, arritmias y ACV. La pasta base tiene dosis más erráticas que hacen mayor el riesgo de sobredosis. El tratamiento del consumo de sustancias es multidisciplinario: psicoterapia cognitivo-conductual, grupos de pares, intervención familiar y eventualmente fármacos. El objetivo es la abstinencia; la minimización de daños es la última opción. Los fármacos usados son: disulfiram (aversivo al alcohol), naltrexona/acamprosato (desmotivadores del consumo) y bupropión/vareniclina (reducen el craving, usados en cesación tabáquica y otras adicciones). La entrevista motivacional evalúa la disposición al cambio y tiene 5 etapas: precontemplativa (niega el problema), contemplativa (reconoce el problema pero no quiere dejarlo), preparación (quiere dejarlo pero no ahora), acción (ejecuta el plan de abstinencia) y mantención (preserva la abstinencia y previene recaídas). El médico debe dar el consejo médico siempre y adaptar su intervención a la etapa en que se encuentra el paciente.